Cabinet de dermatologie Es-Senia

تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-bcn20000-m5-v3 الإصدار 3.0.0 (الملف: كامل)

المريض	P-2026-0428	تاريخ التحليل	14:56 29/10/2026
العمر (بالسنوات)	50	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	ذكر	الموضع	الطرف السفلي
الآفة المتابعة	رقم 1	عتبات القرار	الأصلية

عاجل

اشتباه في ورم ميلانيني

يتجاوز احتمال الورم الميلانيني عتبة الأمان. يوصى بعرض الحالة بسرعة على طبيب الأمراض الجلدية.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «ورم ميلانيني»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
ورم ليفي جلدي	57,0%	نعم
وحمة ميلانينية	25,2%	
ورم ميلانيني	16,4%	نعم
سرطانة الخلايا القاعدية	1,3%	
تقرن حميد	0,1%	
آفة وعائية	0,0%	
تقرن سفعي / داء بوين	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,03 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة الخاصة به.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	0/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	2/6	أزرق رمادي، أسود
D — القطر	11,6 مم	أكثر من 6 مم

تنبيه: تلامس الآفة حافة الصورة: المعايير A وB وD أقل موثوقية.
قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

لم يراجعها طبيب بعد.

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: بحث — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) + BCN20000 (Hernández-Pérez et al., Sci Data 2024, doi:10.1038/s41597-024-03387-w) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).